دليل مساعد لاهم النقاط الواردة في
دليل التدخلات العالمي لراب الفجوة العلاجية في الصحة النفسية



اعداد

د. رياض الرديني

مدير شعبة الصحة النفسية

دائرة الصحة العامة

٢٠١٨/٨/١

اليوم الاول/ مفاهيم الصحة النفسية:

١) مامفهوم الصحة النفسية وهل هي مرادف لمفهوم الاضطراب النفسي؟

- **الصحة النفسية** هي ليست الخلو من المرض النفسي. او العجز الذي يسببه بل هي حالة من العافية التي يستطيع فيها كل فرد ادراك امكاناته الخاصة والتكيف مع مصادر الاجهادات العادية في الحياة، والعمل على نحو منتج ومثمر والإسهام الايجابي في مجتمعه. وان محددات الصحة النفسية عديدة وتشمل صفات الإنسان الفردية (صفاته الوراثية وقدرته على إدارة أفكاره وعواطفه وسلوكياته وتفاعلاته مع الآخرين)، اضافة الى عوامل صحية واجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وبيئية تحيط به مثل سلامة الصحة البدنية, الدفء العائلي وتماسك الاسر, التنشئة الاجتماعية, التربية والتعليم السليمين, الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة, شبكات الدعم الاجتماعي, الموروثات الثقافية والاجتماعية السائدة, وحماية حقوق الانسان.
  - يحدث المرض النفسي نتيجة تفاعل معقد بين تلك العوامل.
- **اما الاضطراب النفسي.** فهو مصطلح يستخدم لوصف الامراض النفسية الرئيسية (القلق, الاكتئاب, الاضطراب الوجداني ثنائي القطب, الفصام, الوهم) ومجموعة الاضطرابات الاخرى التي يمكن تشخيصها بما في ذلك اضطرابات السلوك, اضطرابات الشخصية, اضطرابات النوم والاكل, الاضطرابات النفسية الجنسية, الاضطرابات النفسية المتعلقة بتعاطي الكحول وسوء استخدام المواد, صعوبات التعلم واضطراب طيف التوحد وغيرها.

٢) ماهي اسباب الاضطرابات النفسية؟

- **الاسباب الممهدة: وتشمل الاستعداد الوراثي** (وجود عامل وراثي لدى العائلة), **المرحلة الجينية للشخص** ما تعرضت له الام اثناء الحمل من امراض او اشعاع وما تناولته من عقاقير, **التعرض للشدة اثناء الوضع (الولادة)** سوء الرعاية الصحية للام الحامل في الولادة والنفاس والاطفال بعد الولادة, **العوامل النفسية والاجتماعية التي تعرض لها الفرد في بداية حياته** كاليتم، التشرد، الأعتداء الجنسي، و **السمات الشخصية للفرد.**
- **الاسباب المرسبة: وتشمل الشدة النفسية** (الكروب, العنف المنزلي, العنف باشكاله وانتهاك النساء والاطفال), **الامراض العضوية** (مثل الامراض القلب, الشيخوخة, والعجز), **سوء استخدام العقاقير**(معاقرة المخدرات), **المتغيرات الاجتماعية** (العزلة الاجتماعية, انعدام الامن والامل), و**الأزمات الاقتصادية** (الفقروالبطالة)
- **الاسباب المديمة: وتشمل العوامل الاجتماعية** كموقف الاخرين من المريض كأن يكونون الاهل والاقارب او موقف رئيس الدائرة او المعلم او الاخرين منه, **المرض المزمن والعجز او العاهة المستديمة, و الاضطراب النفسي بذاته** فمثلاً في حالاة الرهاب يتجنب المريض الشيء الذي يرهبه كالطائرة مثلا وعدم مواجهة هذا الخوف يديم الاضطراب ويزيد من شدته.

٣) لماذا دليل التدخلات العالمي لراب الفجوة العلاجية في الصحة النفسية mh GAP-IG ؟

أطلقت منظمة الصحة العالمية في عام ٢٠٠٨ برنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية mhGAP، للتصدي لانعدام تقديم الرعاية النفسية من خلال زيادة قدرة نظام الرعاية الصحية الأولية على تقديم حزمة رعاية متكاملة تشمل الصحة النفسية للافراد والمجتمعات. حيث ان:

- (١/٥ لديهم مشاكل نفسية)
- (١/٥ من الذين لديهم مشاكل نفسية يتلقون العلاج)
- (١/١٠٠ من الملاكات الطبية والصحية قادرة على تقديم خدمات نفسية)

٤) **ماهي الحالات المرضية التي تم اختياره في هذا الدليل ولماذا؟**

تم اختيار مجموعة حالات مرضية باعتبارها ذات الأولوية حيث تمثل عبئاً كبيراً من حيث الوفيات أو المراضة أو العجز، ولأنه يترتب عليها تكاليف اقتصادية باهظة وترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان. وهي مرتبة حسب الاولوية ومخصص لون مختلف لكل وحدة للتمييز بينها بسهولة. مع وجود مقدمة في بداية كل وحدة تستعرض الحالة (الحالات) التي تغطيها الوحدة. وهذه الحالات هي:

- الاكتئاب،
- الذهان،
- اضطراب الثنائية,
- الصرع,
- الاضطرابات النمائية (الأطفال واليافعين),
- الاضطرابات السلوكية (الأطفال واليافعين)،
- الخرف (كبار السن)
- اضطرابات تعاطي الكحول، وسوء استخدام المواد,
- إيذاء الذات/ الانتحار،
- الشكاوي العاطفية الخطيرة, او غير المفسرة طبياً. (اخرى)

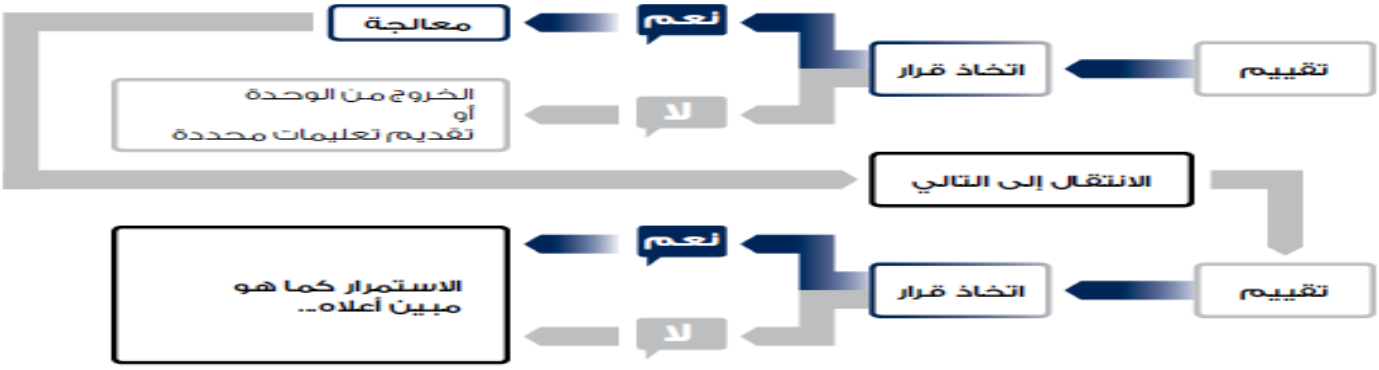
٥) **كيفية استخدام دليل التدخلات في برنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية؟**

وجود «مخططاً رئيسياً » (ماستر جارت) في الدليل والغاية منه هو إرشاد الأطباء إلى الوحدات المتعلقة بعملهم.

ويعتمد الدليل في استخدامه على ٣ اعمدة وهي:

- **عمود التقييم :**يتضمن تفاصيل تقييم الشخص وعلى المستخدم النظر في جميع عناصر هذا العمود قبل الانتقال إلى العمود التالي.
- **عمود اتخاذ القرار:** يحدد الاحتمالات المختلفة التي يمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يواجهها.
- **عمود المعالجة:** يقدّم اقتراحات حول كيفية معالجة هذه المشكلة ويحتوي على معلومات حول التدخلات النفسية والدوائية المفترضة.

في حال وجود مراضة مشتركة (وجود اضطرابين متزامنين) ينبغي معالجة الحالة الأخطر أولاً ثم متابعة الحالات الاخرى في الزيارات القادمة بعد حدوث تحسن في الاعراض. على سبيل المثال، إذا كان الشخص مصاباً بنوبة نفسية حادة فينبغي معالجة النوبة الحادة أولاً ثم الحصول على تاريخ مفصل حول وجود اي اضطراب اخر.



تعليمات لاستخدام الجداول بشكل صحيح وشامل

٦) الدليل ولماذا التركيز على الرعاية الصحية الاولية؟

الفكرة الخاطئة والشائعة على نطاق واسع هي أن العمل في مجال الصحة النفسية **يتطلب تقنيات متطورة ومكلفة وموظفين على درجة عالية من التخصص.** والحقيقة هي أن معظم الحالات في الدليل يمكن أن يديرها مقدمو رعاية صحية غير متخصصين من خلال التدخلات النفسية والاجتماعية والدوائية. **واعتمدت الرعاية النفسية الاوليةلانها:**

- **سهلة الوصول**
- **متوفرة وغير مكلفة**
- **وتعطي نتائج افضل**
- **تقلل الوصم الاجتماعي**
- **وتعزز الاحترام وحقوق الانسان**

٧) من هم المستهدفون بالتدريب؟

يستهدف بالتدريب ملاكات الرعاية الصحية على المستوى الأول والثاني (غير المتخصصة بالصحة النفسية اي من غير الاطباء او الباحثين النفسيين) وبالاخص: الأطباء العامين، و أطباء الأسرة، والممرضين في الرعاية الصحية الاولية, وملاكات الطوارئ والعيادات الخارجية والملاكات الطبية والصحية غير المتخصصة في الرعاية الصحية الثانوية.

٨) ماهي المبادئ العامة لرعاية ذوي الاضطرابات النفسية؟

- ❑ **مبادئ التواصل (اسس المقابلة)**
- ❑ **مبادئ التقييم (التشخيص)**
- ❑ **مبادئ التدبير (العلاج) والمتابعة**
- ❑ **مبادئ تقليص الضغوط النفسية وتعزيز الدعم الاجتماعي**
- ❑ **مبادئ حماية حقوق الإنسان**
- ❑ **مبادئ التنبه للرفاه العام**

❑ **مبادئ التواصل (اسس المقابلة)**

- ابدء بالتحية + اظهار الود والاحترام.
- قدم نفسك (الاسم, والموقع) + وبين الرغبة في المساعدة.
- اكد على الخصوصية والسرية في المعلومة.
- اخذ وقتك الكافي في المقابلة وخاصة المقابلة الاولى.
- تحدث بأمورعامة قبل سؤاله عن مرضه وعدم الضغط على الشخص للتكلم.
- اعتمد على الاسئلة المفتوحة واستخدم لغة بسيطة و واضحة.
- الاصغاء الجيد + كن صبورا وتجنب اصدار الأحكام المسبقة في جميع الأوقات.
- كن متعاطفاً ومراعياً للفروق في العمر والجنس والثقافة واللغة.
- انتبه للغة الجسد.
- اوجز للشخص ماقاله
- التعامل بحساسية في المعلومات الخاصة ومؤلمة (خاصة القضايا الجنسية أو إيذاء الذات).

مع مراعاة النقاط التالية:

- الانتباه الى طريقة الجلوس في المقابلة.
- الانتباه الى المسافة المطلوبة بينكم
- الاهتمام بالتواصل البصري
- الاهتمام باحتواء المريض وخلق الثقة
- التواصل مع الاطفال (يتم بحضور الاهل) والمراهقين (حاول ان تلتقي بهم لوحدهم)
- التواصل مع مقدمي الرعاية للمريض (بموافقة المريض) واكد على مايلي:
  - التعاطف مع مايشعرون به من الم وضيق
  - وضح للاهل اهمية دورهم الكبير في رعاية المريض
  - وضح للاهل بانك تتمنى ان يساعدوك في علاج المريض

❑ **مبادئ التقييم (التشخيص)**

- الاستفسار عن الشكوى وبصورة تفصيلية. وعن وجود اعراض اخرى.
- الاستفسار عن التاريخ الطبي العام للمريض والادوية التي يستخدمها.
- الاستفسار عن تاريخ الصحي الأسري بما له علاقة بالحالة.
- **الاستفسار عن الاسباب الممهدة** (الاستعداد الوراثي, المرحلة الجينية, مرحلة الولادة والطفولة المبكرة, سمات الفردية للشخص, المشاكل الحالية، وعن الظروف النفسية والاجتماعية كاليتم والتشرد او اعتداء جنسي).
- **الاستفسار عن الاسباب المرسبة** (الضغوط النفسية كالصدمات والعنف باشكاله, المشاكل النفسية والاجتماعية والمعيشية والمالية المسببة للتوتر, امراض عضوية كالقلب والعجز والشيخوخة).
- **الاستفسار عن أي تعاطٍ محتمل للكحول ومواد الإدمانية**
- **الاستفسار عن التعرض للعنف (الجسدي, النفسي, الجنسي)**
- **الاستفسار عن اية افكار او محاولات انتحارية**
- **أثناء المقابلة احرص على ملاحظة:**
  - مظهر المريض
  - مزاج المريض
  - تفكير المريض (وجود اوهام اوهلاوس)
  - سلوك المريض وطريقته في التكلم ومحتوى الكلام
- **قييم شدة الأعراض وتأثيرها على اداءه العائلي وعلى عمله وحياته الاجتماعية.**
- **قييم خطورة الاعراض على الشخص نفسه وعلى الآخرين.**
- **ثم إجراء فحص سريري جسدي عام للتاكد من وجود حالة طبية متزامنة.**

ايضا قيم مقدم الرعاية:

- **من هو مقدم الرعاية الرئيسي؟ ومن هم الاخرون؟ وماهي الرعاية التي يقدموها؟**
- **هل مقدم الرعاية متجاوب؟ هل يعاني من ضغوط؟ هل يشكو من الاكتئاب؟**
- **هل يعاني من مشاكل اقتصادية لرعايته.**

ماهو تاثير حالة الاضطراب النفسي على المريض

- **تاثيرات نفسية**
  - ضغط نفسي مستمر وفقدان الامل
  - اكتئاب
- **تاثيرات جسدية**
  - فقر في الصحة الجسدية
  - اكثر زيارات الى الطبيب
- **تاثيرات اجتماعية**
  - الحرمان من الاصدقاء والعلاقات العائلية
  - العزلة الاجتماعية
- **تاثيرات اقتصادية**
  - فقدان الكسب المادي لابتعاده عن العمل
  - المصاريف الطبية والعلاجية.

❑ **مبادئ التدبير (العلاج) والمتابعة**

- اشرح نتائج التقييم والتشخيص المحتمل.
- وضح واشرح كل خيارات العلاج مع بيان (المنافع والاضرار لكل واحدة)
- الحفاظ على مصداقية النتائج الايجابية للعلاج.
- قدم التثقيف النفسي والدعم النفسي الاجتماعي.
- وضح احتمالية الوصف الدوائي قبل اعطاءه.
- كم متاكدا بان كل شخص فهم خطة العلاج.

ما المقصد من التثقيف النفسي

- التركيز على ماممكن عمله من الشخص وعائلته لتحسين الحالة.
- اهمية شمول ومشاركة الشخص بكل مايتعلق بعلاجه.
- اخذ الوقت الكافي لتوضيح ان اعتماد الرعاية المناسبة يؤدي الى التحسن المطلوب.
- تحديد وتحفيز تفكير الشخص لعمل اشياء جيدة.
- شرح الفعاليات التي كانت مفيدة في السابق.
- شرح الخيارات المتاحة للموارد الاجتماعية.
- تشجيع انماط الحياة الصحية (غذاء صحي, نشاطات منتظمة, اجراء فحوصات دورية)
- نصح الشخص ومن يرعاه على طلب المساعدة الطبية عند الحاجة.

الاستخدام الامين للادوية النفسية

- عالميا: ٥٠% من الادوية مصرفة من قبل الاطباء بشكل غير ملائم, و ٥٠% من المرضى يفشلون في تناولها بالشكل الصحيح. (منظمة الصحة العالمية)

- **الصرف الامين:**
  - وضح التاثير, الوقت الذي يبدء عمل الدواء, اثاره الجانبية.
  - حدد فترة استخدام الدواء والوقت المناسب لتناوله.
  - اخذ موافقة المريض على تناوله.
  - ابدء بجرعة منخفضة, ثم زدها ببطئ.
  - المتابعة بشكل منتظم مع التقيم.

المتابعة

- وضع خطة متابعة واضحة (التاريخ, والشخص).
- تكرار جلسات المتابعة يعتمد على الظروف والامكانيات المتوفرة.
- في جلسات المتابعة راقب المواقع التالية:
  - الاعراض
  - اي اعراض جديدة
  - استمرارية الضغوطات النفسية
  - تاثير الادوية والتزام المريض بالعلاج وتاثيراته الجانبية
  - الربط مع الموارد الاجتماعية

- **مبادئ تقليص الضغوط النفسية وتعزيز الدعم الاجتماعي**
- **تخفيف الضغوط النفسية**

- اعطاء فرصة للشخص بالحديث, ويفضل في مكان يحفظ الخصوصية.
- سؤاله عن الضغوط الحالية.
- تقييم اي حالة اساءة او اهمال او انتهاك لحقوق الشخص.
- عصف ذهني مشترك مع الشخص للحلول او لطرق التاقلم.
- بيان امكانية تقديم اي دعم من افراد العائلة.
- التشجيع على المشاركة في مجاميع المساعدة الذاتية ومجاميع الدعم العائلي.

- **حشد وتقديم الدعم الاجتماعي**

- يجب مراعاة التحديات الاجتماعية التي قد يواجهها الشخص، وملاحظة اثرها المحتمل على الرفاه والصحة البدنية والنفسية
- إشراك من يقوم على العناية أو أحد أفراد أسرة الشخص في رعايته
- تحديد وحشد المصادر المحتملة للدعم الاجتماعي والمجتمعي في المنطقة المحلية، بما في ذلك دعم الإسكان والتعليم والدعم المهني.
- للأطفال واليافعين، التنسيق مع المدارس لحشد الدعم التربوي والاجتماعي
- تعزيز الدعم الاسري والاجتماعي باقامة الروابط مع الاسرة وبتنشيط الانشطة الاجتماعية السابقة مثل التجمعات العائلية, زيارة الجيران, الانشطة المجتمعية.
- تعليم الشخص التعامل والتكيف الايجابي مع الضغوطات النفسية الاجتماعية.
- تدريب الشخص على تمارين الاسترخاء.
- تشجيع المشاركة في مجموعات المساعدة الذاتيةودعم الأسرة self help group

❑ **مبادئ حماية حقوق الإنسان**

- تعزيز العيش باستقلالية في المجتمع وعدم التشجيع على إدخال الشخص إلى الرعاية المؤسسية.
- توفير الرعاية بطريقة تحترم كرامة الشخص، وتراعي الثقافة وتلائمها، وتخلو من التمييز
- التأكد من أن الشخص يفهم العلاج المقترح، ويقدم موافقة حرة وعن دراية على العلاج.
- إشراك الأطفال واليافعين في قرارات العلاج بطريقة تتفق مع قدراتهم المتطورة، ومنحهم الفرصة لمناقشة مخاوفهم بطريقة تراعي خصوصيتهم.
- إيلاء اهتمام خاص للسرية، وحق الشخص في الخصوصية.
- موافقة الشخص على إبقاء القائمين على العناية به لاطلاع بحالته الصحية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالعلاج والتقييم والمتابعة وأية آثار جانبية محتملة.
- الحد من الوصم والتهميش والتمييز.
- تعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية وإدمانية من خلال تعزيز الروابط القوية مع قطاعات التوظيف والتعليم والقطاعات الاجتماعية (بما فيها السكن) وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

❑ **مبادئ التنبه للرفاه العام**

- تقديم المشورة حول النشاط البدني والمحافظة على وزن صحي.
- التثقيف بشأن الاستخدام الضار للكحول.
- تشجيع التوقف عن تعاطي التبغ واستخدام مواد الإدمان.
- التثقيف بشأن السلوكيات الخطرة الأخرى (مثل الجنس غير الآمن).
- إجراء فحوص منتظمة للصحة البدنية.
- تجهيز الناس لتوقع التغيرات النمائية في الحياة مثل البلوغ وانقطاع الطمث، وتقديم الدعم اللازم.
- مناقشة خطط لطرق الحمل ومنع الحمل مع النساء في سن الإنجاب.
- في الازمات: الإرشاد بشأن المسائل الامنية عند عدم ادراك الشخص للاخطار التي تهدد امنه.
- ارشاد الأشخاص المضطربين نفسيا بشأن توفّر الخدمات الضرورية للبقاء والعيش الكريم وموقعها.
- ايجاد اماكن صديقة ومناسبة لكل عمر لتعزيز الصحة النفسية.

اليوم الثاني/ الاكتئاب:

١) كيفية تشخص حالة الاكتئاب؟

حين يعاني الشخص لمدة اسبوعين او اكثر من خمسة أعراض منها اثنان رئيسة على الأقل مع صعوبات في القيام بالعمل أو الأنشطة المنزلية أو الاجتماعية المعتادة.

- ❑ **الاعراض الرئيسية للاكتئاب;**
  - مزاج مكتئب, (معظم اليوم وتقريبا كل يوم).
  - فقدان الاهتمام او الاستمتاع بالانشطة التي عادة ماتكون ممتعة لها.
  - انخفاض مستوى الطاقة او الشعور بالتعب بسهولة.
- ❑ **الاعراض الاخرى للاكتئاب;**
  - انخفاض مستوى التركيز والاهتمام.
  - تدني تقدير الذات والثقة بالنفس.
  - أفكار بالذنب وعدم الجدارة.
  - نظرة قاتمة ومتشائمة للمستقبل.
  - أفكار أو تصرفات لإيذاء الذات أو الانتحار.
  - اضطراب النوم.
  - فقدان الشهية.

٢) متى نعتبر الشخص يعاني من الاكتئاب ثنائي القطب؟

- شخص مشخص سابقا باضطراب ثنائي القطب
- او وجود ٣ او اكثر من اعراض الهوس (mania) في وقت واحد وتستمر لمدة أسبوع واحد على الأقل ، وهي شديدة التاثير على العمل والأنشطة الاجتماعية أو التي تتطلب دخول المستشفى؟
  - **ارتفاع المزاج و / أو التهيج**
  - **انخفاض الحاجة للنوم**
  - **زيادة النشاط ، والشعور بزيادة الطاقة ، وزيادة التكلم أو الكلام السريع**
  - **السلوكيات المتهورة أو الطائشة مثل الإنفاق المفرط, قرارات مهمة دون تخطيط وسلوك جنسي غير منضبط**
  - **فقدان الموانع الاجتماعية العادية مما يؤدي إلى عدم ملاءمةالسلوكيات**
  - **يصرف بسهولة**
  - **احترام الذات بشكل غير واقعي**

٣) متى نعتبر حالة الاكتئاب شديد ويجب احالتها الى الاستشاريات النفسية؟

- إذا عانى المريض لمدة اسبوعين او اكثر من ثمانية اعراض او اكثر من اعراض الاكتئاب المذكورة.
- ائا عانى المريض من تدهور شديد في العمل أو الأنشطة المنزلية أو الاجتماعية.
- في حالة وجود أفكار أو تصرفات لإيذاء الذات أو الانتحار, او وجود خطورة لايذاء الاخرين.
- ائا عانى المريض من اكتئاب ثنائي القطب (نوبات من الاكتئاب مع نوبات من الهوس)
- اذا كان الشخص يعاني من المظاهر الذهانية (ذهول, هلاوس, اوهام).
- حالة اكتئاب متكررة (مشخص سابقا وحصلت انتكاسة).
- إن أثبتت التدخلات النفسية الاجتماعية عدم فعاليته.

٤) من الضروري سؤال المراة او الطفل المصاب بالاكتئاب عن؟

- **المراة:** وجود حمل ام لا , او احتماليته بالسؤال عن موعد اخر دورة, او انها مرضع.
  - ينبغي تجنب مضادات الاكتئاب قدر الإمكان.
  - إذا لم تكن هناك استجابة للعلاج النفسي. الاجتماعي، يمكن النظر في استخدام أقل جرعة فعالة من مضادات الاكتئاب باستشارة أخصائي.
  - في حالة الإرضاع، يجب تجنب الأدوية طويلة المفعول مثل الفلوكستين.
- **الطفل:** عمر الطفل هل هو دون ١٢ سنة او اكتر من ١٢ سنة.
- **(اذا اقل من ١٢سنة)**
  - يجب عدم وصف الأدوية المضادة للاكتئاب.
  - التثقيف النفسي للوالدين
  - التعامل مع الضغوطات النفسية الاجتماعية الحالية
  - عرض تقديم المتابعة المنتظمة
- **اذا كان الطفل (١٢ سنة فاكثر)**
  - يجب عدم وصف الأدوية المضادة للاكتئاب كخطوة علاج أولى.
  - التثقيف النفسي له وللوالدين
  - التعامل مع الضغوطات النفسية الاجتماعية الحالية
  - برنامج نشاط بدني منظم
  - التدريب على الاسترخاء اوالعلاج بحل المشاكل
  - النظر في إمكانية تقديم علاج العلاقات الشخصية أوالتنشيط السلوكي أو العلاج السلوكي المعرفي (مشدد)
  - إن أثبتت التدخلات النفسية الاجتماعية عدم فعاليتها، يجب النظر في وصف الفلوكستين (وتجنب مضادات الاكتئاب المانعة لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) او مضادات اكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs).
  - عرض تقديم المتابعة المنتظمة

٥) في حالة وجود فقدان شخص عزيز أو خسارة كبيرة أخرى حديثة:

- اتباع اجراءات علاج الاكتئاب ولكن دون النظر في اللجوء لمضادات الاكتئاب
- مناقشة ودعم الحداد/ التأقلم الملائم ثقافياً.من الضروري

٦) عند علاج الاكتئاب مع وجود حالة مرضية متزامنة نقوم بالاتي؟

- علاج كل من الاكتئاب المعتدل إلى الحاد والحالة المتزامنة.
- مراقبة الالتزام بعلاج المرض الطبي المتزامن، لأن الاكتئاب قد يقلل من مدة الالتزام.

٧) كيفية تدبير حالات الاكتئاب؟

❑ **التثقيف النفسي الذي يقدم لحالات الاكتئاب؟**

يقدم للمريض ولاسرته لافهامهم الامور التالية:

- الاكتئاب مشكلة شائعة جدا يمكن ان تحدث لاي شخص.
- يميل المكتئبون الى حمل اراء سلبية غير واقعية عن انفسهم وحياتهم ومستقبلهم.
- يوجد علاج فعال ويستغرق مالايقل عن بضعة اسابيع قبل ان يبدا العلاج بالتخفيف من الاكتئاب ومن المهم الالتزام به.

- أهمية مواصلة التاكيد على:
  - اهمية مواصلة الأنشطة المعتادة و المثيرة لاهتمام المريض أو تمنحه السرور.
  - أهمية الحفاظ على دورة نوم منتظمة (في نفس الوقت ولنفس المدة كما في السابق، وتجنب النوم ألكثير)
  - فائدة القيام بنشاط بدني بانتظام.
  - فائدة الانخراط في الأنشطة الاجتماعية بانتظام، بما في ذلك الأنشطة الاجتماعية الجماعية.
  - لدى كبار السن، أهمية الالتماس المساعدة لمشاكل الصحة البدنية.
  - اخبار الشخص العودة للحصول على المساعدة عندما تحدث أفكار إيذاء الذات أو الانتحار.

❑ **التعامل مع الضغوطات النفسية الاجتماعية الحالية:**

- منح الشخص فرصة للتحدث في مكان يراعي الخصوصية و سؤاله عن فهمه الشخصي لأسباب الأعراض التي لديها.
- سؤال الشخص عن الضغوطات النفسية الاجتماعية الحالية، وتناول القضايا الاجتماعية ذات الصلة وحل المشاكل المرتبطة بالضغوطات النفسية الاجتماعية أو صعوبات العلاقات بمساعدة من الخدمات/ الموارد المجتمعية.
- تقييم ومعالجة أية حالة من سوء المعاملة والاساءة (مثل العنف المنزلي) والإهمال (مثل إهمال المريضة او الاطفال). والاتصال بالموارد القانونية والمجتمعية حسب الحاجة.
- تحديد أفراد الاسرة الداعمين و إشراكهم بأكبر قدر ممكن وملائم.

❑ **إعادة تنشيط الشبكات الاجتماعية:**

- تحديد الانشطة الاجتماعية السابقة للشخص التي استانفها, سيكون له القدرة على توفير الدعم النفسي. المباشر او غير المباشر (مثل التجمعات العائلية، الخروج مع الأصدقاء، زيارة الجيران، الأنشطة الاجتماعية في أماكن العمل، الرياضة، الأنشطة المجتمعية).
- البناء على نقاط القوة لدى المريض وقدراته، وتشجيعه على استئناف الأنشطة الاجتماعية السابقة.

❑ **برنامج نشاط بدني منظم والتدريب على الاسترخاء**

- تنظيم أنشطة بدنية معتدلة المدة (٤٥ دقيقة مثلاً) ٣ مرات في الأسبوع.
- العمل مع الشخص لاكتشاف أي نوع من الأنشطة البدنية التي يفضلها، وتقديم الدعم له ليزيد تدريجياً كمية النشاط البدني، بدءاً على سبيل المثال بخمس دقائق من النشاط البدني.
- التدريب على تمارين الاسترخاء.

❑ **استخدام العقاقير لعلاج الاكتئاب وكيفية استخدمها؟**

- لا يجب معالجة الشكوى من خلال حقن أو علاجات غير فعالة أخرى (مثل الفيتامينات).
- استخدام فلوكستين٢٠ ملغم (١x١, ٢x١)
- او امبرامين ٢٥ملغم (١x١, ٢x١) ليلا
- حيث تعطى العقاقير بجرعاة بسيطة ثم تزداد تدريجيا وحسب استجابة المريض.
- إخبار الشخص و أسرته عن:
  - التأخر في حدوث أثر العلاج.
  - ان مضادات الاكتئاب لا تسبب الادمان.
  - ان مضادات الاكتئاب فعالة في علاج الاكتئاب ومنع تكرار حدوثه على حد سواء.
  - بالآثار الجانبية المحتملة وضرورة طلب المساعدة على الفور في حال كانت هذه الآثار تسبب الضيق.
  - ضرورة تناول العقاقير المضادة للكآبة لفترة ٦ أشهر بعد الشفاء لمنع تكرار وقوعها ويجب تقليل الجرعة بصورة تدريجية على مدى ١-٢ شهر.

❑ **عرض تقديم المتابعة المنتظمة**

- القيام بمتابعة منتظمة (مثلاً، إما بشكل شخصي في المركز الصحي, أو عن طريق الهاتف).
- إعاد تقييم الشخص لمعرفة ان كان هناك تحسنا (بعد ٤ اسابيع).

الذهان:

١) **ماهي اعراض مرض الذهان؟** هي متلازمة تمتاز بفقدان البصيرة, الهلاوس, والاوهام وسعة انتشاره ١٠٠/١ او ٢٠٠/١
- تغيير سلوكي ملحوظ
- اهمال واضح لمسؤولياته في العمل, او المنزل, او الفعاليات الاجتماعية
- التهيج او السلوك العدواني
- انخفاض او زيادة في النشاط
- معتقدات خاطئة ثابتة لايشاركها الاخرين ضمن الثقافة السائدة
- سماع اصوات او رؤية اشياء غير موجودة
- عدم ادراك الشخص ان لديه مرض نفسي

٢) **الفرق بين الانفصام واضطراب الوهم؟**
- **في الانفصام** يحدث خلل في اغلب النواحي العقلية (التفكير, الكلام, عدم التمييز الحقيقي من غير الحقيقي, تضعف الاستجابة العاطفية, ويفقد بصيرته), يظهر الانفصام في عمر ١٥-٢٥ سنة.
- **في اضطراب الوهم** تظهر فكرة خاطئة واحدة او اكثر غير قابلة للتغيير وتظهر الاعراض في عمر ٣٠- ٤٠ او اكثر. وغالباً يتعايش المريض مع حالته المرضية ولكنها أحياناً تؤثر بصورة شديدة في تصرفاته وعلاقته بمن حوله وتدفعه إلى إلحاق الأذى (وربما ارتكاب جريمة) بحق المقربين إليه نتيجة شعوره الإضطهادي تجاههم مما يستوجب المعالجة الفورية بالعقاقير المضادة للذهان ومن قبل الطبيب الإختصاصي.

٣) **بامكان علاج حالات الذهان في الرعاية الصحية الاولية للاسباب التالية:**
- العلاج الطبي بسيط وفعال
- سهولة اكثر للوصول للمراكز الصحية من الاماكن التخصصية
- اقل وصمة من الاماكن التخصصية

٤) **ماهو مال المرض الذهاني؟**
- شفاء تام او جزئي (وجود بعض اعراض المرض)
- شفاء تام مع وجود انتكاسات مستقبلية
- ذهان مزمن (تستمر الاعراض لثلاثة اشهر او اكثر)

٥) **كيفية تقييم حالات الذهان؟**
- قييم وجود حالات طبية **جسدية:**
  - حسب التاريخ المرضي أو الفحص السريري أو النتائج المخبرية ، هل توجد علامات وأعراض **هذيان** بسبب حالة جسدية حادة، مثل الالتهابات، الملاريا الدماغية، الجفاف، الاختلال ايضي.كنقص سكر الدم أو نقص الصوديوم؛ أو الآثار الجانبية للدواء بسبب بعض الأدوية المضادة للملاريا أو الستيرويدات.
- قييم وجود حالة **خرف او تسمم** دوائي او كحولي او اعراض انسحابية.
- قييم وجود حالة **هوس** (mania)حادة: من خلال وجود اعراض الهوس التي ذكرت سابقا.
- قييم وجود هالة **ذهان** من خلال وجود وجود على الاقل اثنان من اعراض الذهان التالية:
  - **الأوهام والمعتقدات الخاطئة الثابتة التي لا يشاركها الآخرون في ثقافتهم**
  - **الهلوسة أو سماع الأصوات أو رؤية الأشياء غير الموجودة**
  - **الكلام غير المنظم و / أو السلوك، مثل خطاب غير متماسك او ذي صلة مثل الغمغمة (التكلم مع النفس) أو الضحك مع النفس، أو مظهر غريب ، أو علامات إهمال الذات ، أو الظهور بشكل غير مهذب.**

٦) ماهي خطوات تدبير حالات الذهان؟

- توفير التثقيف النفسي للشخص واسرته.
- تقليل التوتر وتعزيز الدعامات الاجتماعية.
- تعزيز الأداء في الأنشطة اليومية.
- بدء العلاج المضاد للذهان.
  - البدء بجرعة منخفضة ضمن النطاق العلاجي و
  - زيادة ببطء إلى أقل جرعة فعالة ، من أجل الحد خطر الآثار الجانبية.
- ضمان سلامة الشخص وسلامة الآخرين.
- دعم إعادة التأهيل في المجتمع.
- توفير المتابعة المنتظمة.

٧) ماهو التثقيف النفسي الذي يقدم لحالات الذهان؟

يقدم للمريض ولاسرته,

- وضح ان الاعراض والعلامات هي ناتجة عن مرض نفسي
- افهامهم قدرته على الشفاء, وتقليل المعاناة والمشاكل بالعلاج والالتزام به,
- مساعدتهم على تقبل حالة المريض ومداراته وما يتطلبه من الصبر والأناة,
- لا تلوم الشخص او اسرته او تتهمهم بالسبب لاعراضه,
- اهمية تجنب التمييز, الاضطهاد, والانتقاد المستمر أو الشديد أو العدائية تجاه الشخص الذهاني.
- صعوبات التعافي أو العيش حياة طبيعية في بيئات عمل أو معيشة شديدة التوتر فلابد من تغيير تلك البيئات
- الحاجة الى اخذ الادوية والمتابعة المنتظمة ومكثفة في بادئ الامر.
- حق الشخص في أن يشارك في كل القرارات التي تتعلق بعلاجه.
- وضح ان عودة او تفاقم الاعراض واردة وهذا يتطلب المراجعة العاجلة للمؤسسة الصحية.
- التخطيط لعمل منتظم أو جدول مدرسي وأن يشغل نفسه بأمور مجدية لتجنب النوم,
- توصيل رسائل إضافية لأفراد ألاسرة من انه قد يسمع أصواتاً أو يعتقد اعتقاداً راسخاً بأشياء غير صحيحة. وان عادة ما لا يوافق الشخص بأنه مريض ويمكن أن يُظهر عدائية بعض الأحيان.
- التوصية بتجنب الكحول ، والقنب أو الادوية غير الموصوفة، لأنها يمكن أن تزيد من اعراض الذهان,
- تقديم المشورة لهم حول الحفاظ على نمط حياة صحي, مثل النظام الغذائي المتوازن ، والنشاط البدني ، والنوم المنتظم ، الحفاظ على نظافة الشخص، تجنب الضغوط فالإجهاد يمكن أن يفاقم من اعراض الذهان.

ملاحظة: يجب أن تستمر تغييرات نمط الحياة لمدة طويلة حسب الحاجة ، وربما إلى أجل غير مسمى.

نصائح لمقدم الخدمات الصحية:

- لا تحاول إقناع الشخص بأن معتقداته تجارب خاطئة أو غير حقيقية.
- حاول أن تكون محايدًا وداعما، حتى عندما يظهر الشخص سلوكًا غير عادي.
- تجنب التعبير عن النقد أو العداوة المستمرة أو الشديدة اتجاه الشخص المصاب بالذهان.
- امنح الشخص حرية الحركة. تجنب تقييد الشخص ، مع ضمان أمنهم الأساسي والاخرين.
- بشكل عام ، من الأفضل للشخص أن يعيش مع العائلة أو أعضاء المجتمع في بيئة داعمة خارج وضع المستشفى. ويجب تجنب الاستشفاء على المدى الطويل.

٨) كيفية تقليل التوتر وتعزيز الدعامات الاجتماعية؟

- التنسيق مع الموارد الصحية والاجتماعية المتاحة لتلبية احتياجات الصحة الجسدية والنفسية الاجتماعية للأسرة.
- حدد الأنشطة الاجتماعية السابقة للشخص، والتي باستعادتها يمكن ان توفر بشكل مباشر او غير مباشر دعم نفسي. والاجتماعي مثل التجمعات العائلية، نزهات مع الأصدقاء، زيارة الجيران، الأنشطة الاجتماعية في مواقع العمل، الرياضة، والأنشطة المجتمعية, وشجع الشخص على استئناف هذه الأنشطة الاجتماعية وتقديم المشورة لأفراد الأسرة حول هذا الموضوع.
- شجع الشخص واسرته على تحسين أنظمة الدعم الاجتماعي.

٩) كيفية تعزيز الأداء في الأنشطة اليومية؟

- المواصلة المنتظمة للانشطة الاجتماعية والتعليمية والمهنية قدر الإمكان. من الأفضل أن يكون للشخص وظيفة أو أن يكون مشغول بامور نافعة.
- تسهيل الإندماج في الأنشطة الاقتصادية
- تقديم التدريب على المهارات الحياتية و / أو التدريب على المهارات الاجتماعية لتعزيز مهارات المعيشة المستقلة.
- تسهيل ، إذا كان ذلك متاحًا ومطلوبا، العيش المستقل والسكن المدعوم والمناسب ثقافيا ضمن سياق المجتمع.

١٠) دعم إعادة التأهيل في المجتمع.

- تنسيق التدخلات مع العاملين الصحيين ومع زملاء العاملين في الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال الإعاقة.
- تيسير الربط مع الموارد الصحية والاجتماعية المتاحة لتلبية الاحتياجات الصحية الاجتماعية والنفسية للأسرة.
- حث الشخص على استئناف الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والمهنية بما يتلاءم ووضعه، وتقديم المشورة لأفراد أسرته حول ذلك. وتيسير إشراكه في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك برامج التوظيف المدعوم الملائمة اجتماعياً وثقافياً. فالأشخاص الذين يعانون من ذهان يتعرضون للتمييز في كثير من الأحيان ولذلك من المهم التغلب على التحامل والتحيز على المستويات الداخلية والخارجية والعمل على تحقيق أفضل نوعية ممكنة من الحياة. كما يجب العمل مع المؤسسات المحلية لاستكشاف فرص العمل أو التعليم وفق احتياجات الشخص ومستواه المهاري.
- إذا لزم وكان متاحاً، استكشاف فرص دعم السكن/ الرعاية الدائمة. يجب النظر بعناية في قدرات الشخص الوظيفية وحاجته إلى الدعم من خلال تقديم المشورة وتسهيل الترتيبات الأمثل للسكن، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوقه الإنسانية.

١١) ماهي العقاقير التي تستخدم في علاج الذهان؟

- زابيركسا Olanzapine ٥ملغم ١x١
- او ٢x١ او سرينيز Haloperidol ٥ ملغم ١x١ ليلا.
- ينبغي وصفها عن طريق الفم بشكل روتيني للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ذهاني.

١٢) من أجل السيطرة الفورية على الأعراض الذهانية الحادة ينبغي مايلي:

- البدء بوصف الأدوية المضادة للذهان على الفور بعد التقييم.
- البدء بجرعات منخفضة وزيادتها ببطء إلى أدنى جرعة فعالة من أجل الحد من الآثار الجانبية.
- تجربة الدواء في جرعته المثلى لما لا يقل عن ٤- ٦ أسابيع قبل التفكير في كونها غير فعالة.

١٣) توفير المتابعة المنتظمة.

- الأشخاص الذين يعانون من الذهان يحتاجون متابعة منتظمة
- ينبغي أن تكون المتابعة الأولية حثيثة قدر الإمكان، حتى إنها يجب أن تكون يومية، إلى أن تبدأ الأعراض الحادة بالاستجابة للعلاج. وبمجرد تجاوب الأعراض، يوصى بمتابعة شهرية إلى فصلية استناداً إلى الحاجة السريرية وعوامل الجدوى مثل توفر الموظفين، والبُعد عن العيادة، وما إلى ذلك.
- المحافظة على مستوى واقعي من الأمل والتفاؤل خلال فترة العلاج.
- خلال كل زيارة متابعة، يجب تقييم الأعراض والآثار الجانبية للأدوية والالتزام بها. فعدم الالتزام بالعلاج أمر شائع، لذلك فإن اشراك القائمين على العناية بالشخص خلال هذه المراحل أمر بالغ الأهمية.
- تقييم ومعالجة الحالات الطبية المتزامنة.
- تقييم الحاجة لتدخلات نفسية اجتماعية في كل زيارة متابعة.

//

اليوم الثالث/

الاضطرابات النمائية:

١) انواع النمو لدى الاطفال مختلفة اهمها؟

- **النمو الجسدي:** وهو نمو الجسم والاعضاء.
- **النمو الحركي:** وهو التطور الحركي للاطفال.
- **النمو الحسى:** وهو نمو الحواس المختلفة ويبدء من الولادة (البصر - السمع - اللمس - التذوق – الشم).
- **النمو العقلي (الادراكي):** وهو نمو الإدراك والوعي (التمييز بين الأشخاص والأشياء المختلفة).
- **النمو اللغوى:** وهو التطور اللغوي من الصراخ والاصوات في البداية للتعبير عن احتياجاته، ثم استخدام بعض الكلمات البسيطة، ثم تقوى لغته تدريجياً.
- **النمو العاطفي:** وهو نمو المشاعر المختلفة التدريجي للطفل.
- **النمو الاجتماعي:** والبناء التدريجي للعلاقات مع الاخرين.

٢) ماهي اهم الاضطرابات النمائية المشار اليها في دليل راب الفجوة؟

- التخلف العقلي.
- التوحد.

٣) كيفية تحديد الطفل الذي يعاني من تأخر في النماء؟

- استخدام مقايس النماء المحلية أو مقارنة الطفل مع أطفال آخرين من نفس العمر في نفس البلد. (تحديد العمر الذي بدأ فيه الطفل بالابتسام، الجلوس، الوقوف بنفسه، المشي، الكلام، فهم التعليمات، التواصل مع الآخرين.)
- للأطفال الأكبر: نستخدم كل ماذكر اعلاه الإضافة الى ملاحظة مدى قدرتهم على القيام بالواجبات المدرسية أو الأنشطة المنزلية اليومية.
- استخدم معامل الذكاء الذي يقاس حسب العمر لمعرفة مستوى النمو العقلي. حيث يعتبر الذكاء طبيعياً إذا كان ٩٠ - ١٢٠ درجة أما الفئة الواقعة بين ٧٠ إلى ٩٠ فهي فئة بطيئي التعلم ومعامل الذكاء للمصابين بالتاخر العقلي فيكون ما دون ٧٠ درجة.

البحث عن:

- تاريخ عائلي من الاضطراب النمائي.
- وجود إعاقة بصرية و سمعية.
- صرع مقترن.
- علامات مقترنة من الإعاقة الحركية أو الشلل الدماغي.
- شذوذ في التواصل (عدم ا ستخدام المهارات اللغوية اجتماعياً، أو الافتقار إلى المرونة في استخدام اللغة).
- أنماط سلوك واهتمامات وانشطة ضيقة النطاق ومتكررة.
- فقدان مهارات مكتسبة من قبل.

٤) متى تكتشف حالات التخلف العقلي؟

يعتمد اكتشاف الحالة على شدة التخلف وكمايلي:

- غالباً ما تُكتشف حالات التأخر العقلي المتوسطة والشديدة من قبل عمر السنتين.
- اما حالات التخلف البسيط وهي الاكثر شيوعا فقد يتاخر اكتشافها في سن الطفولة, وتلاحظ الحالة للمرة الاولى عند شخص مراهق أو بالغ وتظهر المشكلة عندما يواجه الشخص مسؤوليات وضغوطات جديدة في الحياة.

اضطراب طيف التوحد

٥) اهم الخصائص التشخيصية لاضطراب طيف التوحد؟

الاكثر بين الذكور من الاناث ١/٤ وتبلغ نسبة الإصابة به ١% من الاطفال.

ينمو جسديا بشكل طبيعي ويشخص هذا المرض بعمر ثلاث سنوات ويتميز بثلاث صفات:

- **صعوبات في التواصل الاجتماعي والتفاعل العاطفي:** ومن علاماته تجنب النظر في عيون الآخرين، وعدم إظهار الفرح أو السعادة عند ملاطفته أو حمله ومداعبته والمرح مع الآخرين.
- **صعوبات في التواصل اللغوي:** حيث لا يمتلك أية قدرة على الكلام أو أنه يتكلم بشكل غير طبيعي مثل تكرار ما يقال أمامه بشكل ببغائي أو استعمال الضمائر بشكل معكوس.
- **يؤدي حركات غير طبيعية:** حيث تكون حركاتهم خرقاء وغير هادفة ومكررة, مثل:
  - يتعاملون مع الأشخاص وكأنهم أشياء (يمسك بيد أمه ليحرك بها كرته وكأن يد أمه عصا),
  - يهتمون بأجزاء صغيرة من ألعابهم ويحطمون باقي أجزاء اللعبة
  - يقومون بحركة ثابتة لفترة طويلة (إغلاق وفتح الباب لمدة طويلة بدون ملل)
  - الإصرار على طقوس معينة مثل الكيفية التي يقدم بها طعامه أو الإصرار على وجود أشياء معينة وعند تغيير أي من هذه الطقوس يغضب ويحتج بعنف
- **قد يترافق هذا المرض نوبات من الصرع أو حالات التخلف العقلي.**

٦) ماهو دور الرعاية الصحية النفسية في حالات الاضطرابات النمائية؟

تلعب الرعاية النفسية الاولية دورا مهما من خلال متابعة تنفيذ جملة من الخدمات الصحية التي تقدمها الوحدات الاخرى في الوقاية من الاضطرابات النمائية.

- توفير الرعاية والوقاية من سوء التغذية والعدوى في الحوامل وعلاجها. بالإضافة إلى توفير الولادة الآمنة ورعاية المولود بعد الولادة. والوقاية من إصابات الرأس، والالتهابات العصبية و سوء التغذية لدى الرضع والأطفال الصغار.

- تحديد مجموعات الأطفال الذين يعانون سوء التغذية أو يصابون بالمرض كثيراً وغيرهم من الأطفال المعرضين للخطر وتوفير الرعاية لهم. وترتيب لقاءات مع الأهل أو زيارتهم في منازلهم.
- تدريب الأهل حول كيفية تحسين التفاعل بين الأم والرضيع وكيفية توفير التحفيز النفسي- الاجتماعي للطفل.
- في حال اكتشاف إصابة الأم باكتئاب، البدء بعلاج الأم ويفضل أن يتم ذلك من خلال التدخلات النفسية الاجتماعية.
- تقديم الدعم النفسي- الاجتماعي الإضافي للأمهات المصابات باكتئاب أو أي ا ضطراب نفسي- أو عصبي أو استخدام مواد إدمان آخر. وهذا قد يشمل الزيارات المنزلية، والتثقيف النفسي، وتحسين معرفة الأمهات بممارسات تربية الأطفال.
- ينبغي على النساء الحوامل، أو اللاتي يخططن للحمل النظر في تجنب تعاطي الكحول تماماً، وذلك لأن الدماغ النامي حساس بشكل خاص لآثار الكحول، حتى في الأسابيع القليلة الأولى من الحمل.

التثقيف النفسي (تقبل, تفهم, رعاية خاصة, تاهيل)

- قبول الطفل الذي يعاني من اضطراب نمائي ورعايته.
- معرفة ما يسبب التوتر للطفل وما يجعله سعيداً، وما يسبب المشاكل السلوكية لديه وما يحدّ منها، ما هي نقاط قوته وضعفه، وأفضل طريقة يتعلم من خلالها.
- إدراك أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نمائية قد يواجهون صعوبات مع المواقف الجديدة.
- تنظيم اليوم بحيث يكون هناك أوقات منتظمة لتناول الطعام واللعب والتعلم والنوم.
- إشراكهم في الحياة اليومية، بدءاً بمهام بسيطة كل على حدة.
- إبقاؤهم في المدرسة إلى أقصى حد ممكن، ويفضل تسجيلهم في مدارس عادية وان كان بدوام جزئي.
- الحرص على نظافتهم العامة وتدريبهم على الاعتناء بأنفسهم.
- مكافأة سلوكهم الجيد بعد أن يقوموا به، وحجب المكافأة عندما تكون هناك مشكلة سلوكية.
- حمايتهم من الإساءة.
- احترام حقهم في أن يكون لديهم منطقة أمان ضمن حدود يمكن مراقبتها، حيث يمكن أن يشعروا بالأمان والراحة والتحرك بحرية واللعب بالطريقة التي يريدونها.
- التواصل وتبادل المعلومات مع أهل آخرين لديهم أطفال يعانون من حالات مماثلة.

تقديم المشورة للمعلمين.

- وضع خطة بشأن كيفية التعامل مع احتياجات الطفل التعليمية الخاصة.
- وابداء نصائح بسيطة:
  - الطلب من الطفل الجلوس في مقدمة الصف.
  - إعطاء الطفل وقتاً إضافياً لفهم الواجبات.
  - تقسيم الواجبات الطويلة إلى أجزاء أصغر.
  - التحسب لوجود تنمّر ضد الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقفه.

تقديم الدعم الممكن لاسرة الطفل.

- تحديد التأثير النفسي الاجتماعي على القائمين على العناية بالطفل.
- تقييم احتياجات القائمين على العناية بالطفل وتعزيز توفير الدعم والموارد اللازمة لهم من حيث الحياة الأسرية والعمل والأنشطة الاجتماعية والصحة. وعمل ترتيبات رعاية مؤقتة، والتي تعني حصولهم على استراحة بين الحين والآخر عندما يتولى أشخاص آخرون جديرون بالثقة العناية بالطفل مؤقتاً.

الاضطرابات السلوكية

١) ماهي اهم الاضطرابات السلوكية المشار اليها في دليل راب الفجوة؟

- اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
- الاضطراب السلوكي العدواني.
- وهي الاضطرابات الاكثر انتشارا بين الاطفال
- المشكلة انه قد تستمر جزء من الصفات معهم حتى مرحلة البلوغ

٢) ماهي الخصائص التشخيصية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه؟

- هو الاكثر انتشاراً بين **الذكور** عن الاناث يصل الى ١٠٪ ويقل مع تقدم عمر الطفل
- يشخص **بعمر ٦ سنوات** تبدء الاعراض بالظهور في سن مبكرة (قبل سن٦ سنوات) وتدوم مدة طويلة (أكثر من ٦ أشهر) وغير مقتصرة على إطار واحد.
- **الحركة الزائدة:** فيتسم بالشعور بالتقلقل المفرط، لاسيما في المواقف التي تتطلب هدوءاً نسبياً. فقد يقوم الطفل أو المراهق بالركض والقفز، أو النهوض عن مقعده عندما يُفترض به البقاء فيه، أو الثرثرة المفرطة و إحداث ضجة، ومقاطعة الآخرين مما يسبب مشكلات في التعلّم والدراسة.
- **صعوبة التركيز وتشتت الأنتباه:** ويمتاز بترك المهام وعدم إنجاز الأنشطة، والانتقال من نشاط إلى آخر بشكل كبير, سهولة الالتهاء عن الواجب, التململ, وقلة النظام والترتيب.لكن لا يجب تشخيص هذه المشاكل في الانتباه والمواظبة على المهام بأنها اضطراب إلاّ إذا كانت مفرطة بالنسبة لسن الطفل أو المراهق وذكائه، وتؤثر على قدرته على التعلم وعيش حياته بشكل طبيعي.
- **الاندفاعية واللاأبالية:** يفعل أشياء فجأة من دون التفكير فيها مما يسبب تحطيم ألاشياء في المنزل بدون قصد وعدم القدرة على انتظار دوره في لعبة ما أو الإفراط في الحديث أو إحداث ضجة.
- ان الأعراض ملحوظة **في مكانين على الأقل** (مثلاً في البيت والمدرسة او غيرها)

٣) ماهي الخصائص التشخيصية لاضطراب السلوك العدواني؟

- **يشخص بعمر ٦ سنوات تبدء الاعراض بالظهور في سن مبكرة (قبل سن٦ سنوات) وتدوم مدة طويلة (أكثر من ٦ أشهر).**
- **السلوكيات العدوانية تقع في أربع فئات:**
  - العدوان على الناس/ الحيوانات: (مستويات مفرطة من العراك أو التنمر),(القسوة مع الحيوانات), (السلوك الاستفزازي والمتحدّي ونوبات غضب حادة ومتكررة).
  - تدمير الممتلكات واشعال النيران.
  - الغش والكذب أو السرقة وتناول الكحول او المخدرات.
  - انتهاك خطير للقواعد (العصيان, التغيب عن المدرسة, الهروب من المدرسة)

- **ملاحظة:** حصول المرض في طفل لايتميز بالعدوانية سابقاً, فقد يكون ناتج عن معاناة الطفل من الكآبة أو من أحد الأمراض (العاطفية) العصابية الاخرى.

- **ملاحظة:** الجنوح في المراهقة يكون مسبوقاً باضطراب السلوك في الطفولة وبعلاقات عائلية تتسم بالاضطراب والعدوانية وبفقدان أحد أو كلا الأبوين، وقد يكون أحد الأبوين مضطرباً نفسياً.

٤) **ماهو التثقيف النفسي الذي يقدم في الاضطرابات النمائية والسلوكية؟** (تقبل, تفهم, رعاية خاصة, ادماج)

- اهمية تقبل ان الطفل يشكو من اضطراب نفسي
- تفهم احتياجات الطفل وتوفيرها
- إدراك أن الطفل قد يواجه صعوبات مع المواقف الجديدة
- تدريب الأهل على كيفية توفير بيئة محفزة للطفل
- معرفة ما يسبب التوتر للطفل وما يجعله سعيداً، و أفضل طريقة يتعلم من خلالها
- رعاية الطفل وتوفير الدفء والحنان العائلي
- الحرص على نظافتهم العامة وتدريبهم على الاعتناء بأنفسهم.
- تنظيم اليوم بحيث يكون هناك أوقات منتظمة لتناول الطعام واللعب والتعلم والنوم
- الامتناع التام عن الإساءة للطفل جسدياً أو عاطفياً.
- مكافأة سلوكهم الجيد، وحجب المكافأة عند العكس.
- إشراكهم في الحياة اليومية، بدءاً بمهام بسيطة.
- إبقاؤهم في المدرسة قدر الامكان، وادماجهم في المدارس العادية حتى لو كان ذلك بدوام جزئي.
- احترام حقهم في أن يكون لديهم منطقة أمان ضمن حدود يمكن مراقبتها، حيث يمكن أن يشعروا بالأمان والراحة والتحرك بحرية واللعب بالطريقة التي يريدونها.

٥) **ماهو الدعم الممكن تقديمه لاسرة الطفل ذو الاضطراب النمائية والسلوكية؟**

- النظر في توفير التدريب للأهل على تعليم المهارات
- النظر في توفير التدخلات النفسية والتدريب على المهارات الاجتماعية
- دعم الأسرة لتتمكن من التعامل مع المشاكل الاجتماعية والأسرية التي تؤثر على الطفل.
- تقييم تأثير الاضطرابات النفسية على الاسرة ودعم احتياجات صحتهم النفسية.
- معالجة اكتئاب عند اصابة احد الوالدين به.
- علاج الاضطرابات العاطفية أو وجدانية المسببة للحالة عند الطفل

٦) **ماهي الاحتياجات التعليمية و المشورة التي يمكن تقديمها للمعلمين في الاضطرابات النمائية والسلوكية؟**

- تعزيز فرص الالتحاق بالمدرسة وغيرها من أشكال التعليم.
- توفيرالاحتياجات التعليمية الخاصة.
- صفوف خاصة لضمان زيادة أنتباه الطفل وتجنب تشتته.
- التعليم المتخصص الثنائي (معلم و طالب او عدد صغير محدود من الأطفال)
- مدرسة داخلية (تعليم خاص وسيطرة على السلوك وتأهيل) .
- **اما المشورة التي يمكن تقديمها للمعلمين فهي:**
  - الطلب من الطفل الجلوس في مقدمة الصف.
  - إعطاء الطفل وقتاً اضافياً لفهم الواجبات.
  - تقسيم الواجبات الطويلة إلى أجزاء أ صغر.
  - التحسب لوجود تنمّر ضد الطفل واتخاذ الإجراءات المنا سبة لوقفه.

٧) ماهي الادوية التي تستخدم في علاج الاضطرابات السلوكية في الرعاية الصحية الاولية؟

- يجب عدم استخدام الأدوية للاضطرابات السلوكية لدى الأطفال واليافعين من دون استشارة أخصائي.
- لا يجب النظر في استخدام المنبهات لعلاج اضطراب فرط الحركة إلاّ إذا فشلت التدخلات النفسية الاجتماعية، وتم إجراء تقييم دقيق للطفل و عمره لا يقل عن ٦سنوات، ويتم استبعاد الحالات التي أن تتعقد باستخدامها.
- الأدوية: قد تكون مهمة جداً للسيطرة على فرط الحركة ومن ثم زيادة الأنتباه والتركيز وتستعمل مشتقات الأمفيتامين (وهي من المنبهات) واللارجكتيل والستراتيرا (المهدئات الكبرى). وتصرف من قبل الطبيب المختص.
- يجب أن يكون استخدام الأدوية المنبهة دائماً جزءاً من خطة شاملة للمعالجة تشمل التدخلات النفسية والسلوكية والتربوية.
- يجب المواظبة على تسجيل كمية الدواء التي يتم وصفها وتاريخ الوصفة، فضلاً عن الاستجابة والآثار الجانبية، في السجلات الطبية.

ملاحظات حول العلاج الدوائي: يجب اجراء التقييم التالي:

- تقييم جهاز القلب والشرايين
- اخذ الطول والوزن.
- تقييم مخاطر وجود استخدام لمواد الإدمان وتحويل الدواء لشخص آخر.
- وجود أمراض طبية مثلاً الصرع مع اضطراب نقص لانتباه مع فرط النشاط.
- وجود اضطرابات نفسية أخرى فقد يفاقم القلق، وممنوع استخدامه في حالة الذهان.
- يجب عدم وصف الميثيل فينيديت دون إشراف أخصائي.

المتابعة:

- يجب إيقاف العلاج إذا لم يكن هناك استجابة بعد شهر واحد.
- يجب أخذ وزن الطفل كل ٣ أشهر وطوله كل ٦ أشهر. وفي حال توقفت الزيادة في الوزن أو الطول، يجب إيقافه.
- إذا استجاب الطفل للعلاج، يستمر عليه لمدة سنة واحدة. ومن ثم يتم استشارة أخصائي للتأكد إن كان هناك ما يبرر مواصلة استخدامه..

//

اليوم الرابع/

التعاطي والادمان

١) مالفرق بين التعاطي والادمان؟

- **التعاطي او سوء استخدام المواد:** هو تناول الفرد لمواد تسبب الادمان ولم تظهر عليه بعد خصائص الادمان , قد تكون مواد محظورة او مواد غير محظورة (العقاقير الطبية) قانونيا.
- **الادمان (الاعتمادية):** هو حالة تعود قسري مزمن على تعاطي مادة معينة من المواد المخدرة بحيث يكون الاعتماد عليها (نفسيا, وعضويا).

٢) ماهي خصائص الادمان؟

- اعتماد المدمن نفسياً وبدنيا (الرغبة القهرية والمتسلطة) على المادة المخدرة.
- الميل إلى زيادة الجرعة المعطاة من المادة المخدرة ولمدد أطول للحصول على نفس الاستجابة.
- الانشغال الزائد بالاستخدام أو بمحاولات التوقف عنه.
- ظهور ألاعراض الإنسحابية في حالة عدم الحصول على المادة المخدرة.

٣) كيف تقسم المواد المخدرة؟

- **الأولى: (المجموعة الطبيعية)** أى المواد التى تنبت تلقائياً أو تزرع وتستعمل كما هي مثل: الحشيش بأنواعه ،القات ، الأفيون، النباتات المهلوسة والكوكايين, والتبغ.
- **الثانية: (المجموعة المصنعة) وهى أدوية تستخدم أساساً للأغراض الطبية تم إساءة استخدامها واستعملت فى سوق المخدرات مثل :** الهيروين والأدوية المهدئة الصغرى مثل الباربتورات والمبروباميت والبتروديازيم وكذلك عقاقير الهلوسة المصنعة والمنشطات مثل الامفيتامين.
- **الثالثة: (مجموعة المواد الطيارة)** وهي مواد تستنشق مثل البنزين، الصمغ (الغراء), مزيلات الطلاء إضافة إلى أنواع أخرى كالكحول والمنومات.

٤) العراق الان في اي مرحلة من المراحل المتعلقة بمخاطر المواد المخدرة؟

- **العراق لايزال في مرحلة النشوء او الولادة, واسباب الخطر تكمن في:**
  - الازمات الاقتصادية
  - الفوضى الاجتماعية
  - العنف المتواصل لسنوات طوال واثاره
  - ضعف سلطة الدولة
  - انتشار الجماعات المسلحة
  - أزدياد الاتجار بالمخدرات
  - الحدود المفتوحة وغير المسيطر عليها مع دول الجوار
  - سهولة الحصول على المواد المخدرة وضعف الرقابة
  - الامية في المواد المخدرة وازدياد معدلات التعاطي سنويا

٥) لماذا يعتبر الحقن الوريدي للمواد المخدرة من اخطر وسائل ادخال المواد الى الجسم؟

- خطورة الاصابة بفايروس نقص المناعة المكتسب
- خطورة الاصابة بالتهاب الكبد الفايروسي (سي, دي)
- الموت المبكر نتيجة للجرعات العالية
- شدة الاعتمادية والادمان
- الالتهابات الجلدية في اماكن زرق الابر
- فقدان القدرة على تادية الوظائف (العائلية, العمل) ومخالفة القوانين

٦) ما العلاقة بين الادمان والاضطرابات النفسية؟

- الادمان والاضطرابات النفسية عوامل خطر متبادلة.

٧) اهم تاثيرين للادمان هما؟

- الاعتماد الفسيولوجي
- العجز المعرفي والعاطفي والسلوكي

٨) تحديد شدة الادمان في الرعاية الصحية الاولية يعتمد على الوسائل التالية؟

- الاستفسار عن التالي (نوع المادة الادمانية, طريقة الادخال, مدة التعاطي, وشدة الاعراض الانسحابية للشخص)
- تقييم (ASSIST scoring)

٩) ماهي التدخلات البسيطة التي نعتمدها في حالات الادمان؟ (5A)

- Ask السؤال عن التعاطي لكل مراجع لوحدة الصحة النفس اجتماعية.
- Advise النصح لببيان ايجابيات ترك المادة الادمانية
- Assess حدد ارادة الشخص ورغبته لترك المادة الادمانية
- Assist ساعد الشخص لاتخاذ قرار ترك المادة ونجاحه في ذلك
- Arrange اعطاء الشخص معوضات المادة الادمانية والمتابعة المستمرة مع تخفيف تدريجي في الجرعات

١٠) تصنف شدة الادمان في تقييم (ASSIST scoring) على مجموع النقاط في نهايته وبالشكل الاتي؟

- الادمان البسيط من (١-٣)
- الادمان المتوسط (٤- ٢٦)
- الادمان الشديد (٢٧+)

١١) علاج الادمات يتطلب ثلاث وسائل؟

- تحديد شدة الادمان
- ازالة سموم الادمان من الجسم
- التاهيل النفسي لمنع العودة

الخرف

١) الخرف هو متلازمة تتسم بمايلي؟

- حدوث تدهور تدريجي في الذاكرة **(مرض في الدماغ وذو طبيعة مزمنة ومتزايدة).**
- إضطراب الإدراك للزمان والمكان والأشخاص.
- تغير في الشخصية وفي التفكير والسلوك.
- تدهور في القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

٢) يتطلب الكشف عن الخرف مايلي؟

- **تقييم الذاكرة والأداء المعرفي**
  - التقييم الزماني (الوقت من اليوم، يوم الأسبوع، الموسم، السنة)
  - التقييم المكاني (أين يتم فحص الشخص، أو أين يقع أقرب سوق أو متجر من منزله).
  - تقييم الذاكرة بتكرار الشخص ثلاث كلمات شائعة على الفور، واعادتها مرة أخرى بعد ٣- ٥ دقائق.
  - تقييم المهارات اللغوية والمعرفية عن طريق الطلب من الشخص تسمية بعض أعضاء الجسم، او شرح وظيفة شيء ما، مثل"ماذا نفعل بالمطرقة؟"
- **مقابلة شخص مطلع يعرف المريض جيدا والاستفسار منه عن كل المتغيرات التي حدثت في التقييم اعلاه.**

٣) ماهو دور وحدات الصحة النفس اجتماعية في حالات الخرف؟ (راجع التفاصيل في المحاضرة)

- **التثقيف النفسي للفرد واسرته (تفهم, تقبل, رعاية, تاهيل) اعلام المريض والاهل بمايلي:**
  - بان الخرف هو مرض يصيب الدماغ، وفي العادة يسوء مع الوقت.
  - لايوجد علاج له، ولكن هناك الكثير مما يمكن القيام به لمساعدة ودعم الشخص والأسرة.
  - يمكن التعامل مع الكثير من المخاوف والسلوكيات المحددة حال نشوئها.
  - يمكن القيام بالكثير لجعل الشخص أكثر راحة وجعل الحياة أقل إرهاقاً للقائمين على العناية به.

التدخلات النفسية الاجتماعية للتعامل مع الأعراض المعرفية والأداء المعرفي

- تقديم معلومات منتظمة خاصة بالتوجه المكاني/ الزماني (مثلا اليوم، التاريخ، الوقت، الطقس، أسماء الأشخاص) لمساعدتهم على المحافظة على توجههم الزماني والمكاني والشخصي.
- استخدام مواد مثل برامج الإذاعة أو التلفزيون أو الصحف، وألبومات العائلة، وأغراض المنزل لتعزيز التواصل معهم، وجعلهم على اطلاع على مستجدات الأحداث، وتحفيز ذكرياتهم، وتمكينهم من تشارك تجاربهم وتثمينها.
- استخدم جمل قصيرة بسيطة لجعل التواصل الكلامي واضحاً. ومحاولة تقليل الأصوات التي قد تشوّش على الانتباه أثناء الحديث، مثل الراديو أو التلفزيون أو المحادثات بين آخرين. والإصغاء بانتباه لما يقوله الشخص.
- المحافظة على البساطة في كل شيء، وتجنب تغيير الروتين أو تعريض الشخص لأماكن غير مألوفة وغريبة إلا إذا كان ذلك ضرورياً.

تقديم النصح لتعزيز الاستقلالية والقدرة على أداء الأعمال اليومية والحركة

- تقديم المشورة حول الحفاظ على الاستقلالية في استخدام التواليت بما في ذلك تحفيز وتنظيم تناول السوائل (في حالة سلس البول، ينبغي تقييم جميع الأسباب المحتملة وتجربة خيارات العلاج قبل الاستنتاج بن الحالة دائمة).
- إخبار أفراد الأسرة بأهمية المحافظة على أرضية المنزل دون فوضى للحد من خطر الوقوع.
- اقتراح إدخال تعديلات على منزل الشخص. فقد يكون مفيداً إضافة منحدر للكرسي المتحرك، كما يمكن وضع إشارات عند الأماكن الرئيسية (مثل التواليت، غرفة النوم، الحمّام) للمساعدة على ضمان ألاّ يضيع الشخص أو يشعر بالتوهان في المنزل.
- نصح الشخص بممارسة النشاط البدني والرياضة للحفاظ على القدرة على الحركة والحد من خطر الوقوع.
- نصح الشخص بالمشاركة في أنشطة ترفيهية (مصممة خصيصاً لمرحلة الخرف).
- الإحالة إلى العلاج الوظيفي (مثل ضعف البصر-والسمع) باستخدام الأجهزة المناسبة (مثل، عدسة مكبرة أو معينات سمعية).
- لابد من الفحص والتأكد من وجود الأسباب المرضية المشابه للخرف والتي يمكن علاجها إذا شخصت مبكراً مثل أستسقاء الدماغ الذي يعالج جراحياً, أو حالات قلة إفراز الغدة الدرقية أو نقص فيتامين ب١٢والنياسين أو السفلس.

تدخلات لمساعدة القائمين على العناية بالمريض.

- الاعتراف بأن العناية بالمصابين بالخرف يمكن أن تكون محبطة ومرهقة للغاية. ومن المهم أن يستمر هؤلاء الأشخاص في العناية بالمصاب بالخرف، وتجنب التصرف بعدائية معه أو إهماله, كما يجب تشجيعهم على احترام كرامة المصاب بالخرف.
- بما أن الأشخاص الذين يعانون من الخرف معرضون للإساءة والإهمال، ينبغي على مقدمي الرعاية الصحية أن يكونوا متيقظين لحماية المصاب بالخرف.

اليوم الخامس/

الشكاوى العاطفية الخطيرة أو الأخرى غير المفسرة طبياً

١) من هم الاشخاص الذين يقعون ضمن وحدة الشكاوى العاطفية الخطيرة أو الأخرى غير المفسرة طبياً؟

- هذه الوحدة في الدليل تهدف التى اعتماد صيغة لتدبير مجموعة من الاضطرابات النفسية التي لا تتواجد في بقية وحدات الدليل والتي تؤثر على الاداء الوظيفي اليومي للفرد او ان الشخص يشعر بالضيق النفسي يدفعه الى طلب المساعدة العلاجية ومن تلك الاضطرابات. مثال ذلك:
  - اضطراب نفسي جسدي الشكل،
  - اكتئاب جزئي,
  - اضطراب القلق ،
  - اضطرابات الهلع،
  - اضطراب التكيف.
  - التفاعل الحاد للكرب،
  - اضطراب الكرب التالي للصدمة ،
- لاينبغي اللجوء الى هذه الوحدة الا في حالة استبعاد كل الحالات ذات الاولوية الموجودة في الدليل ومنها الاكتئاب المعتدل الى الحاد ماعدا ايذاء النفس.

٢) ماهي الاعراض المعتادة للشكاوى العاطفية الخطيرة أو الأخرى غير المفسرة طبياً؟

- الشعور بالتعب الشديد أو الاكتئاب أو الغضب أو القلق أو التوتر.
- شكوى جسدية غير مبررة طبيا (أي أعراض جسدية لا تملك سبب مادي معروف يفسر تماما الأعراض).

٣) ماهي الاجراءات التي تتخذ في حالة الشكاوى العاطفية الخطيرة أو الأخرى غير المفسرة طبياً؟

- **التقييم:**
  - تاكد اذا كان هناك سبب جسدي يفسر.تماما الأعراض, ان كان نعم فيجب معالجة السبب الجسدي ومتابعة زوال تلك الاعراض.وان كان لا فيجب
  - التاكد اذا كانت هناك اعراض تفسر في اي وحدة من وحدات الدليل, ان كان نعم فيجب الذهاب الى تلك الوحدة في الدليل واتباع الاجراءات اللازمة فيه وان كان لا فيجب
  - التاكد اذا كان الشخص يسعى لطلب المساعدة لزوال الاعراض او ان هناك تاثير واضح على الاداء الوظيفي اليومي للفرد, ان كان لا فلا توجد ضرورة علاجية وان كان نعم فان هناك احتمالية لوجود شكاوى نفسية خطيرة اخرى لذلك يجب
  - التاكد من تعرض الفرد الى ضغوط نفسية شديدة مثل (العنف الجسدي أو الجنسي، الحوادث الكبرى ، الفجيعة أو خسائر كبيرة أخرى), فان كان نعم فالذهاب الى بروتوكول (١,٢) وان كان لا فالذهاب الى بروتوكول (١)
  - قيم في احتمالية ايذاء النفس او الانتحارقبل البدء في بروتوكل (١,٢)

التدبير:

بروتوكول (١) الشكاوى النفسية الخطيرة الأخرى

- لا توصف أدوية مضادات الاكتئاب او القلق (الا باستشارة متخصص).
- لا تعطي حقن الفيتامينات أو غيرها من العلاجات غير الفعالة.
- في جميع الحالات، الحد من التوتر وتعزيز الدعم الاجتماعي.
  - معالجة الضغوطات النفسية والاجتماعية الحالية.
  - تعزيز الدعم المتوفر.
  - تعلم إدارة الإجهاد مثل تقنيات الاسترخاء.
- عندما لا يتم تحديد أي حالة جسدية تفسر بشكل كامل ألاعراض الجسدية، فسر حقيقة الأعراض وقدم التفسيرات المحتملة.
  - تجنب طلب المزيد من الاجراءات المختبرية أو غيرها من الفحوصات ما لم تكن هناك اشارة واضحة لمشكلة طبية.
  - في حالة إجراء مزيد من الفحوصات لسبب ما تجنب التفسيرات غير الواقعية من خلال إخبار الشخص أن النتيجة المتوقعة من المرجح أن تكون طبيعية.
  - إبلاغ الشخص بأنه لم يتم تحديد أي مرض خطير من خلال نتائج الفحص السريري والمختبري.
  - إذا أصر الشخص على إجراء مزيد من الفحوصات، فاخبره بان اجراء مزيد من الفحوصات يكون ضار لانها تزيد من توتره وتسبب اثار جانبية ضارة.
  - الإقرار بأن الاعراض التي يعاني منها ليست خيالية وأنه من المهم معالجة الأعراض التي تسبب ضائقة كبيرة.
  - اسأل الشخص عن تفسيره الخاص لسبب أعراضه، واسأل عن مخاوفه, فقد يعطي أدلة حول مصدر الشدة، والمساعدة في بناءعلاقة ثقة مع الشخص وزيادة التزام الشخص بالعلاج.
  - اشرح أن المعاناة / التوتر العاطفي غالباً ما ينطوي على اعراض جسدية، مثل آلام المعدة، وتوتر العضلات، وغيرها وبين الروابط المحتملة بين مشاعر الشخص/ الإجهادات والأعراض الموجودة.
  - تشجيع الاستمرار (أو العودة التدريجية) للأنشطة اليومية.
  - تشجيع تطبيق ممارسة الحد من التوتر وتعزيز الدعم الاجتماعي.

بروتوكول (٢) الشكاوى النفسية الخطيرة الأخرى عند الاشخاص المتعرضين الى ضغوط نفسية شديدة

- في جميع الحالات، سواء كان الشخص يعاني ام لا من المشاكل العاطفية أو السلوكية أو الجسدية بعد التعرض لضغط شديد, قدم الدعم كما موضح في بروتوكول (١)
- استمع بعناية.
- لا تضغط على الشخص للتحدث عن الحدث.
- اعمل على تلبية احتياجات الشخص الاجتماعية.
  - اسأل الشخص عن احتياجاته واهتماماته.
  - مساعدة الشخص على تلبية الاحتياجات الأساسية, والوصول إلى الخدمات والتواصل مع الأسرة وسبل الدعم الاجتماعي الأخرى.
  - حماية الشخص من الاذى إذا لزم الأمر.
  - شجع الشخص للعودة إلى الأنشطة العادية السابقة, كالتي في المدرسة أو العمل, في المنزل، واجتماعيا، إذا كان ذلك ممكنا ومناسب ثقافيا.

- **في حالة حدوث أي خسارة كبيرة ،** قم بشرح الآتي:
  - من الطبيعي أن تحزن على أي خسارة كبيرة. يمكن للمرء أن يحزن على شخص، مكان، أو ممتلكات أو على فقدان المرء صحته ورفاهه. الحزن له اثار على الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء.
  - يحزن الناس بطرق مختلفة, بعض الناس يظهرون مشاعر قوية بينما لايفعل الآخرون ذلك. البكاء لا يعني أن الانسان ضعيف. الناس الذين لا يبكون قد يشعرون بالالأم بنفس العمق ولكن لديهم طرق أخرى للتعبير عنه.
  - وضح ان في معظم الحالات، الحزن سيتضاءل مع مرور الوقت. قد يعتقد المرء أن الحزن أو الشعور بالألم لن يختفي أبداً في حين تقل هذه المشاعر بمرور الوقت.
  - في بعض الاحيان قد يشعر الفرد بتحسن لفترة من الوقت، ثم شيء يذكره بالحادث فيعاود الشعور بالسوء كما كان في البداية.
  - لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة في التعبير عن الحزن, ففي بعض الأحيان قد يشعر المرء بالحزن الشديد وفي أحيان أخرى بخدر، وفي أوقات أخرى قد يستطيع المرء أن يمتع بنفسه. هذه التجارب عادة ما تصبح أقل كثافة وأقل تواترا مع مرور الوقت.
- **في حالة فقدان أحد أفراد أسرته،** ناقش تقدم الدعم المناسب ثقافيا واجراءات عملية الحداد.
  - اسأل ما إذا كانت اجراءات الحداد/ الطقوس المناسبة قد حدثت أو تم التخطيط لها. إذا لم يكن هذا هو الحال ، ناقش العقبات وكيفية معالجتها.
- **اذا اشتبه في اضطراب الحزن الطويل,** فقم باستشارة أحد المختصين لمزيد من معلومات التقييم والتدبير.
  - قد يعاني الشخص من اضطراب الحزن الطويل إذا كانت الأعراض تشمل صعوبة كبيرة مع العمل اليومي لمدة ٦ أشهر على الأقل وتشمل الانشغال الشديد أو الشوق الشديد للشخص المتوفى يرافقه ألم عاطفي شديد.
- **في حالة وجود ردود فعل لتعرض الشخص الى حدث صادم ، اشرح ما يلي:**
  - غالبا ما يكون لدى الناس ردود فعل بعد هذه الأحداث. قد تكون التفاعلات شديدة التغير من شخص لآخر والتغيير بمرور الوقت.
  - يمكن أن تشمل الأعراض الجسدية مثل الخفقان، والأوجاع والآلام، واضطراب المعدة، والصداع والأعراض العاطفية والسلوكية التي تشمل اضطراب النوم, الحزن والقلق والتهيج والعدوانية في بعض الاحيان.
  - يمكن أن تتفاقم هذه المشاعر أو يمكن أن تعاود الظهور عند التذكير بالحادث أو حدوث ضغوط نفسية جديدة.
  - في معظم الحالات ، من المرجح أن تقل الأعراض بمرور الوقت ، خاصة إذا توفرت للشخص الراحة والدعم الاجتماعي ويمارس تمارين الحد من التوتر.
- **إذا اشتبه في اضطراب الكرب ما بعد الصدمة (PTSD)،** فاستشر أخصائيًا لمزيد من التقييم والتدبير.
  - بعد وقوع حدث صادم محتمل ، قد يكون الشخص يعاني من اضطراب الكرب ما بعد الصدمة إذا كانت الأعراض تنطوي على صعوبة كبيرة في القيام بالنشاط اليومي لمدة شهر واحد على الأقل مع حدوث احلام مخيفة متكررة, استرجاع لذكريات الماضي المؤلمة مصحوبة بالخوف الشديد أو الرعب؛ تجنب متعمد للتذكير بالحدث؛ القلق المفرط والخوف أو ردود فعل قوية واستجابات أو حركات غير متوقعة.

المتابعة:

٤) تفاصيل التقييم :

٥) المتابعة:

- قييم حالة المريض فيما اذا كان هناك تحسن ام لا:
- اذا تحسن المريض استمر في خطة العلاج ومتابعة الحالة حسب الاحتياج.
- اذا لم يتحسن الشخص او ان الشخص نفسه او من يقوم برعايته يصر على اجراء مزيد من الفحوصات والعلاجات يجب احالة الشخص الى المختص.
- توصيات في تكرار المقابلة: الطلب من الشخص العودة بعد ٢-٤ أسابيع من بدء العلاج إذا لم يشعر بتحسن او في أي وقت تزداد أعراضه سوءا.

متطلبات تنفيذ الدورات المحلية حول دليل التدخلات العالمي لراب الفجوة في الصحة النفسية

١) اعداد الدورات يعتمد على عدد وحدات الصحة النفس اجتماعية وعلى تقييم المستوى التدريبي للعاملين فيها.

١) تحديد المستهدفين في الدورة (اصحاب العلاقة وهم الاطباء العمومين, اطباء الاسرة, الملاكات الصحية)

٢) تحديد الهدف من الدورة (تغيير معارف و توجهات وزيادة مهارات)

٣) توفير الدعم المالي لاقامة الدورة,

٤) الاعداد للدورة وتهيئة كافة مستلزماتها مسبقا من حيث:

- دعوة اصحاب العلاقة,
- عدد المشاركين فيها **(الحد الاقصى ٣٠ مشارك)**
- مكان اقامتها, (مكان ملائم لاقامة الدورة بشكل ناجح),
- تحديد الوقت الئي تتطلبة الدورة, **(٥ ايام)**
- الوقت المناسب لاقامتها,
- تحديد اجندة مناسبة للدورة, **(اعتمادا على الاجندة المركزية)**
- تحضير المادة العلمية التي تتطلبها الدورة,
- تجهيز كافة مستلزمات نجاحها, (قرطاسية, دلائل عمل او تدريبية, لابتوب, شاشة عرض)
- استمارة الاختبار القبلي, الاختبار البعدي, استمارة تقييم الدورة والمحاضرين,
- وضع قواعد للدورة يلتزم بها جميع المشاركين,
- اتباع وسائل تدريبية متنوعة والعمل على مساهمة الجميع فيها,
- ابلاغ المحاضرين بموعدها وواجبات كل منهم,
- اعلام المشاركين قبل وقت مناسب من اقامة الدورة للتحضير لها.

٥) المتابعة والزيارات الاشرافية لبيان تاثير الدورة على اداء المشاركين وجودة الخدمات النفسية المقدمة.